جلسه سوم گوارش

اختلالات مری esophageal disorders

مری لوله ای تو خالی است که برای انتقال مواد خورده شده از دهان به معده طراحی شده است

از قاعده حلق شروع و در 4 سانتی متری زیر دیافراگم به پایان می رسد

یک سوم ابتدایی آن عضله مخطط و دو سوم انتهایی از عضله صاف است

در بین دو اسفنکتر فوقانی و اسفنکتر تحتانی قرار دارد

UES باز می شود تا لقمه وارد مری شود و بسرعت بسته میشود تا مانع از برگشت وآسپیراسیون شود

LES در آغاز بلع باز شده وتا زمانیکه لقمه غذا وارد معده نشده باز باقی میماند وسپس بسته می شود تا مانع از ریفلاکس مواد معده به مری شود.

علایم بیماریهای مری

1. pyrusis or heart burn
2. Dysphagia
3. Odynophagia
4. chest pain

سوزش سر دل

- **شایعترین** علامت بیماریهای مری است
- یک احساس سوزش در ناحیه اپی گاستر که به سمت قفسه سینه انتشار می یابد
- بیمار دستش را بین گزایفوییید و زاویه استرنال بالا وپایین می کشد و نشان میدهد
- معمولا بعد از غذا خوردن و دراز کشیدن به پشت و خم شدن و بلند کردن اجسام (افزایش فشار در داخل شکم) احساس می شود
- غذاهای تند و پر چرب و شکلات هم گاها باعث سوزش می شود
- معمولا سوزش سر دل با **آنتی اسید** بر طرف می شود

دیس فاژی

بلع دشوار- اشکال در بلع

بیمار اظهار می دارد که لقمه غذا گیر کرده و یا به آهستگی پایین می رود

ممکن است بعلت:

انسداد مکانیکی مری ، التهاب مخاط مری ،اختلال در حرکات دودی مری ایجاد شود

اودینو فاژی

- بلع دردناک
- بلع دردناک ناشی از ازوفاژیت عفونی(عفونت مونیلیایی) یا زخم مر ی(بدنبال مصرف قرصهای مسکن) است
- بندرت در بیماریهای ناشی از اسید معده دیده می شود

درد قفسه سینه

- این علامت غالبا در اثر ریفلاکس معدی-مروی یا اختلالات حرکتی مری ایجاد می شود
- ممکن است با درد قلبی اشتباه گرفته شود چون مسیرهای انتقال عصب در هر دو عضو مشترک است
- انتشار درد به گردن و فک ، شروع در ضمن فعالیت و تسکین درد با نیتراتها در هر دو عضو یکسان است
- درد سینه ای که بیمار را از خواب بیدار کند بیشتر به نفع اختلال مری است
- درد مری معمولا با آنتی اسید بهبود می یابد

ریفلاکس گاسترو ازوفاژیال GERD

شایعترین بیماری مری است که در 50 % افراد جامعه باعث علایم گهگاه می شود

مکانیسم بیماری:از بین رفتن مکانیسمهای حفاظتی مری است

1 -کاهش ترشح بیکربنات در مخاط مری

2 -کمبود بزاق در بعضی بیماریها که بدنبال آن بیکربنات بزاق هم وجود نخواهد داشت

3 -فقدان حرکات دودی ثانویه مری در بیماریهای حرکتی مری که کار این حرکات ثانویه، پاک کردن مدام مری از اسیدهای پس زده است

علایم بیماری

1 -سوزش سر دل علامت اصلی است

2 - ترش کردن یا احساس مزه ترش و تلخ که بالا آمده اند

3 -سرفه های مزمن بخصوص شبانه

4 -خشونت صدا

4 -گلو درد و احساس گرفتگی گلوی مداوم

تشخیص

1 -رادیو گرافی بلع باریوم

2 -آندوسکوپی که عوارض ریفلاکس مثل ازوفاژیت و زخم ناشی از اسید را نشان میدهد

3 -تشخیص دقیق با پایش PH است ولی بعلت گران بودن و تهاجمی بودن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد

4 - در کل رفع علایم با آنتی اسید معیار تشخیصی خوب و راحتی است

treatment درمان

1 - تغییر شیوه زندگی:

بالابردن سر 15 تا 20 درجه موقع خواب-اجتناب از خوردن غذا یا مایعات 2 ساعت قبل از خواب-اجتناب از غذاهای پرچرب وادویه دار وسیگار والکل- کاهش وزن

2 - درمان دارویی:

الف-خط اول درمان دارویی آنتی اسید های موضعی مثل هیدروکسید آلومینیوم و هیدروکسید منیزیوم 30 دقیقه پس از غذا و پیش از خواب

ب- H 2 بلاکرها:سایمتیدین وفاموتیدین ونیزاتیدین 2 بار در روز

ج-داروهای پیش برنده حرکات دودی:متوکلوپرامید-سیزاپراید 3تا 4 با در روز

د-مهار کننده های پمپ پروتون : PPI امپرازول- لانزوپرازول و پنتوپرازول

در صورت شکست تمام درمانها: جراحی ضد ریفلاکس

عوارض بیمار ی ریفلاکس

1 - ازوفاژیت

2 -زخم ulcer

3 -ایجاد تنگی در مری esophageal stenosis

بدان

دنیا مثل مادرت نیست که ظهر سرش داد بزنی و شب برای شام صدایت کند.دنیا ولت می کند تا از گرسنگی بمیری